

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm on kokku kutsutud süsteemsete muutuste saavutamiseks



Anniki Lai

hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma juht



Rauno Mäekivi

rakkerühma koordinaator

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühm moodustati Riigikantselei juurde Vabariigi Valitsuse otsusega 2015. aasta detsembris. Rakkerühma tegevuse eesmärk on kaardistada lähedaste hooldamisega seotud probleemid ning töötada välja inimeste vajadustest lähtuvad lahendused. Hooldust vajavate inimeste all on sealjuures silmas peetud nii eakaid, puudega täisealisi kui ka lapsi.

Hoolduskoormuse vähendamine on ühelt poolt oluline, et tagada tööturule võrdne ligipääs inimestele, kes ei saa soovitud määral töötada perekonnaliikme hooldamise tõttu. Teisalt on vaja toetada kõrvalabi vajavate inimeste iseseisvat toimetulekut, et neil oleksid võimalused täisväärtuslikuks igapäevaeluks ning ühiskonnas osalemiseks.

Praegune süsteem ei ole ennetav ega toeta inimeste vajadusi

Rakkerühma algatamise seletuskirjas on välja toodud, et 2009. aastal¹ sotsiaalministeeriumi korraldatud puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuringu

kohaselt hooldavad pereliikmed ligikaudu 52 000 puudega 16aastast ja vanemat inimest. Pereliikmete hooldamise tõttu mitteaktiivseid 15–74aastasi inimesi on Eestis 17 400, mis moodustab 1,8% kõigist sellesse vanusegruppi kuulujaist. Hoolduskoormusega hõlmatutest on märkimisväärne hulk naisi (hoolduskohustus on ligi 30 000 naisel ja 17 000 mehel²), kellel on seetõttu vähesemad võimalused tööturul osaleda. Seepärast tuleb lahenduste otsimisel pöörata erilist tähelepanu just nende hoolduskoormuse vähendamisele. Arvestades rahvastiku vananemist ning terviseprobleemidest tingitud kõrvalabi vajavate inimeste arvu kasvu, on hädavalalik teha süsteemis muudatused ning leida lahendused hoolduskoormuse tõttu tööturult

¹ Hoolduskoormuse statistikat ei koguta igal aastal, vaid iga viie aasta tagant läbi viidavate „Puuetega inimeste ja nende pereliikmete hoolduskoormuse uuringu” ning „Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuringu” raames. Uued andmed avaldatakse 2016. aastal.

² Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 2014.

väljuvate või selles mitteosalevate inimeste tööhõives hoidmisele või tagasitoomisele.

Peamised probleemid hoolduskoormuse leevendamisel ja hooldajate tööturul osalemisel on seotud kas teenuste puudumise, vähese kättesaadavuse, valikuvõimaluste või sotsiaalsete garantiide puudumisega.³ Oluliseks vajakajäämiseks on ka vähene või ebapiisav hooldusvajaduse ennetus, mille tõttu inimeste terviseprobleemid süvenevad ja väheneb iseseisev igapäevaelu toimingutega hakkamasaamine kodus. Nii Riigikontroll kui ka OECD on praegust teenuste korraldust kritiseerinud, sest hoolimata deinstitutionaliseerimise suunast paigutatakse meil inimesi pigem kallimale asutusepõhisele hooldusteenusele, arvestamata inimese tegelikke vajadusi.⁴

Üheks kitsaskohaks hooldusvajaduse süvenemise ennetamisel ja pikaajalise hoolduse korraldamisel on eeskätt sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuste vähene lõimitus, mille tõttu inimesed ei saa õigel ajal oma vajadustele vastavaid teenuseid ja olemasolevaid ressursse kasutada ebaotstarbekalt. Näiteks tõi Riigikontroll oma 2015. aasta auditis „Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel” välja, et iseseisva õendusabi ja hoolekande süsteem ei ole seotud tervikuks, statsionaarse õendusabi kättesaadavus ja riiklik rahastamine erinevad piirkonniti ning neil puuduvad ühtsed hindamiskriteeriumid. Auditist selgus, et 25% statsionaarse õendusabi teenust kasutanud patsiente sai 2013. aastal nende vajadustele mittevastavat abi, mis oli ühtlasi ka kõige kallim. Seetõttu kulutati ebaotstarbekalt 4,1 miljonit eurot.

Lahendamist vajavaid probleeme on süsteemis teisigi, nt puuetega inimeste (sh nii laste kui ka täisealiste) hooldajatele võib kohalik omavalitsus maksta hooldamise eest

toetust, kuid toetuse määramise reeglid on omavalitsuseti väga erinevad. Näiteks maksab mõni omavalitsus toetust ainult hooldajale, kes ei tööta; teine omavalitsus ainult puudega laste hooldajatele või siis, kui hooldataval ei ole ülalpidamiskohustusega pereliikmeid jne. Kokkuvõtvalt peamised probleemid:

- teenuste puudumine, ebaühtlane kättesaadavus ja kvaliteet
- sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi teenuste vähene lõimitus (aga ka vähene lõimitus töö- ja haridusvaldkonnaga)
- riigi ja omavalitsuse tegevuse puudulik koordineatsioon
- ebapiisav hooldusteenuste rahastus (OECD 2015 raporti kohaselt olid pikaajalise hoolduse kulud Eestis 0,2% SKPst, OECD keskmine on 1,7%) ning riiklik rahastus seab surve tervishoiusüsteemi rahakotile
- eelistatakse kallist asutuspõhist teenust, hooldusvajaduse süvenemise ennetus on puudulik
- piisavate sotsiaalsete garantiide puudumine omastehooldajatele.

Seega on hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma peamine väljakutse siduda kokku olemasolevad võimalused ja käimasolevad arendused nii sotsiaal- kui ka tervisevaldkonnas ning töötada välja terviklik teadmistel tuginev poliitikalahendus teenuste lõimitud ja efektiivseks korraldamiseks.

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma koosseis ja plaanid

Rakkerühm loodi eeldusega, et hoolduskoormus on valdkond, mis puudutab eri ministeeriume ja osapooli ning mille probleemide lahendamiseks tuleb teha horisontaalset

³ Heaolu arengukava 2016–2023 eelnõu.

⁴ Eakate hoolekande korraldus omavalitsuste hooldekodudes. Riigikontroll 2014; samuti on viidanud probleemile OECD (2011).

koostööd. Rakkerühmas on esindatud sotsiaalministeerium, rahandusministeerium, haridus- ja teadusministeerium, Riigikantselei, Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet, MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Eesti Omastehooldus, MTÜ Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoda, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Tartu Linnavalitsus, Teenusmajanduse Koda, MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Õdede Liit, Eesti Perearstide Selts ning eksperdina Reeli Sirotkina (Tartu Ülikool / Tallinna Ülikool). Rakkerühma tööd juhib ja tegevust koordineerib Riigikantselei juures tegutsev kolmeliikmeline üksus.

Rakkerühma töö jaguneb kahe aasta peale, ajakava järgi peavad poliitikalahendused olema välja töötatud 2017. aasta novembriks. Sealjuures esimese aasta põhiülesanne on kaardistada probleemid sotsiaal- ja tervishoiuteenuste pakumises ja hooldusvajaduse ennetamisel, mis viivad ülemäärase hoolduskoormuse tekkele. Samuti hinnatakse teiste riikide süsteemide plusse ja miinuseid ning püütakse leida Eesti vajadustele sobivad lahendused. Selleks, et siduda kohalike ekspertide, praktikute ja poliitikakujundajate (ehk rakkerühma liikmete) teadmised rahvusvaheliste ekspertide teadmisega, on kesksel kohal laiapõhjaline pikaajalise hoolduse uuring, mis viiakse läbi koostöös Maailmapangaga. Rakkerühma roll siinkohal on uuringu juhtimine, suunamine ja pidev tagasiside andmine, et uuring oleks Eestile ka praktilises mõttes võimalikult asjakohane ning annaks just meile vajalikku teadmist. Uuringu eesmärk on läheneda hoolduskoormuse teemale senisest laiemalt ning kaardistada probleemid erinevate sihtgruppide lõikes (puudega täisealised, puudega lapsed, vanemaealised), võttes

arvesse kohalike omavalitsuste erinevusi ja planeeritavat haldusreformi, teenuste kättesaadavust ning rahastust, hinnates valdkondade koostööd ja teenuste lõimitust.

Uuringu ettevalmistamisega on juba alustatud. Käesoleva aasta jaanuaris külastas rakkerühma juhtrühm koos Maailmapanga eksperdiga nelja eri suurusega omavalitsust (sealhulgas nii linnasid kui ka valdasid). Kahepäevase visiidi eesmärk oli mõista, kuidas on omavalitsustes sotsiaalteenused korraldatud ning arutada omavalitsusjuhtide ja sotsiaalvaldkonna töötajatega peamiste kitsaskohtade üle. Märtsis külastasid Eestit Maailmapanga eksperdid, et paremini mõista Eesti sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi ning nende omavahelist lõimitust ning arutada uuringuga seotud praktilisi küsimusi. Nelja päeva jooksul toimusid kohtumised ekspertide ja spetsialistidega (sh mõnede rakkerühma liikmetega) sotsiaalministeeriumist, rahandusministeeriumist, Eesti Haigekassast, Sotsiaalkindlustusametist, Eesti Statistikaametist ja Tallinna Ülikoolist. Aprillikuu lõpus tutvustasid Maailmapanga eksperdid rakkerühmale esmaseid tulemusi. Uuringu aruanne valmib 2017. aasta veebruariks.

Maailmapanga uuringu tulemustele ja soovitudele tuginedes töötatakse 2017. aastal välja poliitikasuunised ja lahendused (seadusandlus, teenuste korraldus, rahastus jne), mis võimaldavad pakkuda inimeste vajadustest lähtuvaid hoolduskoormust ennetavaid ja vähendavaid sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Kõige olulisem on aga töö käigus hoida silme ees peamist eesmärki, mille täitmiseks rakkerühm on loodud ja mille nimel igapäevaselt tegutseb: võimaldada meie inimestele heaolu ja väarikat elukvaliteeti. **S**

Hoolduskoormuse vähendamise rakkerühma tegevuse kohta leiab lisainfot riigikantselei.ee/hoolduskoormus.